

26. PRAXIS : DIE LUNGEN

DAUER : 05:35

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video konzentriert sich auf den biodynamischen Ansatz der Lunge, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, wie die Kippbewegung der Lunge und die Suche nach dem embryonalen Fulcrum-Punkt entscheidend sind, um ihre primäre Funktion wiederherzustellen. Die Teilnehmer lernen, die Dynamik zwischen Lunge, Pleura und dem umliegenden Gewebe zu beobachten, insbesondere wie Emotionen wie Traurigkeit sich dort festsetzen und die Atmung beeinflussen können. Techniken zur Initiierung eines Gewebedialogs und zur Befreiung von mit Exsudaten überfüllten Pleuraräumen werden ebenfalls behandelt, wobei die Bedeutung der strukturellen und emotionalen Reorganisation der Lunge zur Verbesserung der Atemwegsgesundheit hervorgehoben wird.

LUNGENPRAXIS

Die **hintere Hand** ist etwas tiefer als die **vordere Hand**, die etwas höher ist. Dies liegt an der **Kippbewegung** der Lungen um ihre Achse. Diese Bewegung ist wesentlich, um sich in das **embryonale Feld** der Lungen zu begeben, wo der **embryonale Fulcrum-Punkt** gesucht wird. Dieser Punkt stellt ein Saugfeld dar, das es ermöglicht, sich in der primären Funktion der Lungen zu repotenzieren, d.h. bereit zu sein, den **Atem des Lebens aufzunehmen**.

Während der neun Monate der embryonalen Entwicklung werden die Lungen auf diese erste Bewegung vorbereitet. Sie produzieren **Fruchtwasser**, eine entscheidende Funktion, da der Embryo es zum Überleben benötigt. Diese Flüssigkeit stammt teilweise aus dem Urin der Nieren. Später wird ein **spezifisches Protein** namens **Surfactant** produziert, das die Öffnung der Lungen zum Zeitpunkt der Geburt ermöglicht.

Anfangs ist der ausgeübte Druck sanft. Es geht darum, schrittweise einen Raum wiederzufinden, in dem sich die Lunge organisieren und ihre Freiheit wiedererlangen kann. Zwischen der **viszerale Pleura** und der **parietalen Pleura** gibt es eine Begegnung zwischen der Trachea, dem Bronchus und dem luftführenden Bronchialgewebe, das Luft und ein Restvolumen sowie einen Flüssigkeitsraum enthält.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Gewebe Emotionen beherbergen kann, wie zum Beispiel eine verinnerlichte **Traurigkeit**. Zum Beispiel kann ein Kind, das in seinen Lungen weint oder an Bronchitis leidet, eine Traurigkeit ausdrücken, die es nicht verbalisieren kann. Durch sanfte Arbeit an diesem Gewebe ist es möglich, einen Dialog und einen **oxidativen Gewebeaustausch** einzuleiten.

Durch die **große hintere Fissur** kann man Zugang zu Räumen erhalten, in denen Emotionen verborgen sind. Es ist wesentlich, den Körper arbeiten zu lassen und sich auf die Reorganisationsachse zu konzentrieren. Die **costopleuropulmonalen Rezessus** sind Ansammlungsräume für Exsudate, in denen sich die Abfälle der Lungen ablagern. Diese Zonen, oft weniger beweglich, müssen dynamisiert und befreit werden.

Es ist auch entscheidend, die Lungen von ihren Ansatzpunkten zu befreien, insbesondere von den **Ligamenta suspensoria der Pleurakuppel**. Die Rezessus, wie die **costodiaphragmatischen Rezessus** und der **fremomediastinale Rezessus**, spielen eine wichtige Rolle für die Freiheit des Mediastinums und des Herzens.

Die Produktion von Fruchtwasser beginnt bereits in der **fünften Schwangerschaftswoche** und entwickelt sich bis zur **38. Woche**, wobei das Surfactant um die **25. Woche** herum auftritt. Lungenerkrankungen wie Bronchitis oder Bronchiolitis können Manifestationen sein, die versuchen, ungelöste Probleme aus dem embryonalen Stadium zu lösen, die sich in Form von **Flüssigkeit** äußern. Man kann sagen, dass man "in den Lungen weint".

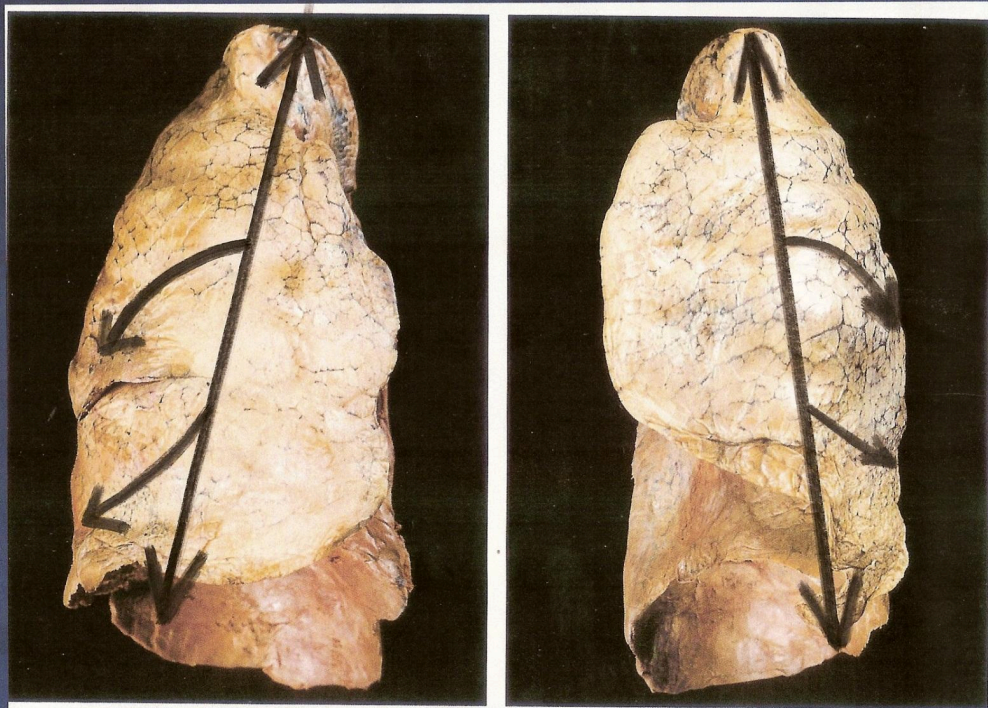


ABB. — Oberer schräger Lappen

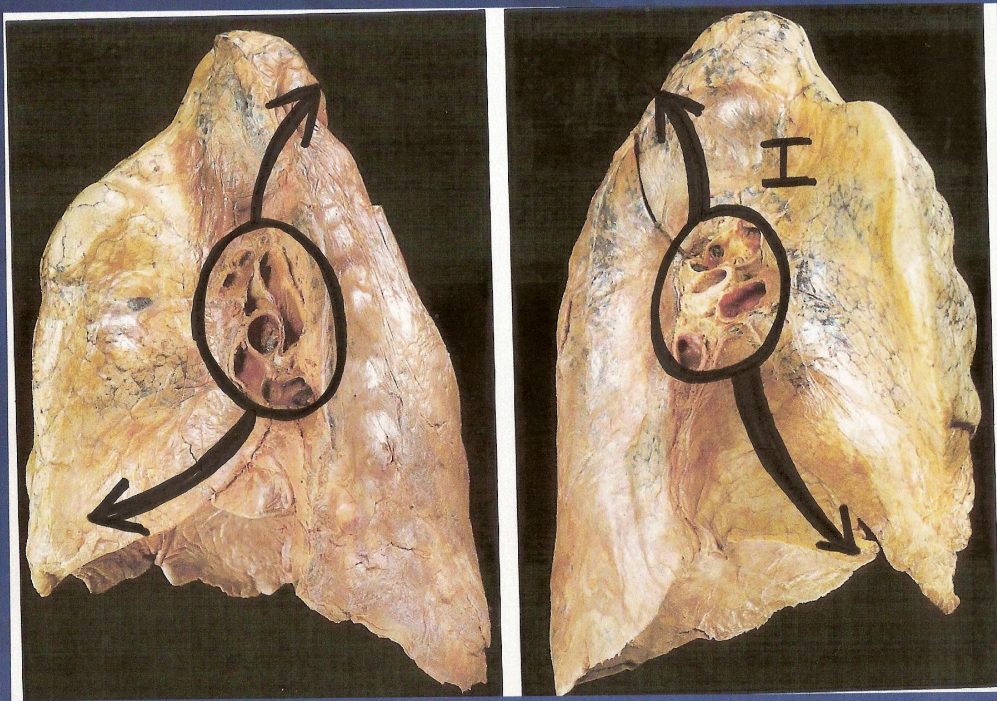


ABB. — Zystische Lungenerkrankung